

RECURSO CÍVEL Nº 5069106-52.2024.4.02.5101/RJ
RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)
RECORRIDO: LUIS FERNANDO TEIXEIRA (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. CARDIOPATIA GRAVE COMPROVADA. PARTE AUTORA PORTADORA DE MARCAPASSO DEFINITIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condene a recorrente vencida em honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa ao juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5069106-52.2024.4.02.5101 510014763748 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5069106-52.2024.4.02.5101/RJ
RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)
RECORRIDO: LUIS FERNANDO TEIXEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré, em face da sentença que jugou procedente o pedido no seguintes termos:

*"Isto posto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, para reconhecer o direito do autor à isenção ao pagamento de imposto de renda.*

Em consequência, declaro o direito da parte autora à isenção de imposto de renda retido na fonte incidente sobre seus proventos de aposentadoria do INSS e de sua aposentadoria complementar (evento 1, anexos 8 e 9), na forma prevista no inciso XIV do art. 6º da Lei n. 7.713/88 e o artigo 35, inciso II, alínea b c/c §4º, III, do Decreto n. 9.580/2018, a partir de 03/08/2020.

Outrossim, determino que a União/FN conceda à parte autora a restituição dos valores descontados a título do referido tributo até o efetivo cumprimento da obrigação de não recolhimento de IR na fonte sobre os proventos de aposentadoria do autor, ressalvadas as parcelas abarcadas pela prescrição quinquenal. "

Alega a parte recorrente não existir comprovação de que o autor é portador de cardiopatia grave.

VOTO

I - Do Direito:

O inciso XIV do art. 6º da Lei 7.713/88 e o inciso XIV do Decreto nº 3.000/99 concedem isenção aos proventos de aposentadoria aos portadores de algumas moléstias;

"Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

.....

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; **(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)**”

Destaco que, as hipóteses legais de isenção devem ser interpretadas restritivamente, ex vi do inciso I do art. 111 c/c inciso I do art. 175 ambos do CTN.

Isenção esta que, contudo, só é devida sobre os proventos de aposentadoria ou reforma e não sobre vencimentos.

Este entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

3. Consectariamente, revela-se interdita a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002.

Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006)

4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”(STJ, RESP1116620/BA, Min Luiz Fux, Primeira Seção, DJE 25/08/2010 p. 19).

II - Do caso concreto:

Narra a parte autora ser portadora de de cardiopatia grave (CID E10 // CID R00 // CID R00.8 // CID R55 // CID E66 // CID J44.9) com implante de Marcapasso (CID Z95.0), pretendendo a repetição de indébito tributário, em decorrência de ser portadora de doença grave, prevista como causa de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física.

Observa-se dos autos que, a parte autora recebe aposentadoria por tempo de contribuição pelo INSS, desde 20/06/1992, recebendo suplementação de aposentadoria pela PETROS (evento 1, outros 6 e 7).

De acordo com declaração emitida pelo Hospital Casa São Bernardo o autor é portador de marcapasso cardíaco desde 2013, tendo realizado a troca do mesmo em 14/03/2023, decorrente de disfunção sinusal grave. Vejamos:

DECLARAÇÃO

Resumo de Internação

Paciente Luiz Fernando Teixeira foi admitido neste nosocomio em 13/03/2023. Veio transferido do Pronto Atendimento da Unimed Barra devido a quadro de síncope e 05 episódios de crise convulsiva relatados. Paciente era portador de Marca-passo definitivo desde 2013 porém sem acompanhamento com arritmologista desde 2019. No momento da chegada ao Pronto Atendimento da Unimed Barra apresentou Eletrocardiograma evidenciando BAVT e frequência cardíaca de 25bpm. Foi passado marca-passo transvenoso com estabilização hemodinâmica do paciente. Paciente chega a este nosocomio com marcapasso transvenoso em Sens 1 | Output 2 e FC 80BPM. FC: 81 BPM | PA: 155X77 MMHG | SATO2: 93% EM AA. No mesmo dia foi avaliado pela equipe de Arritmologia que solicitou pedido para troca de marcapasso definitivo. Paciente mantinha-se lucido e orientado, sem déficit neurológico e mantendo ritmo de marcapasso provisório com frequência cardíaca de 80bpm.

Em 14/03/2023 o paciente foi admitido no setor de hemodinâmica, estável hemodinamicamente e se mantendo durante todo o procedimento. Foi realizada troca do gerador de marcapasso cardíaco definitivo bicameral sob anestesia local e sedação. Foi optado por implantar novo eletrodo no ventrículo direito e sepultar o antigo na loja. O marcapasso provisório foi retirado ao final do procedimento. Paciente permaneceu estável durante todo o procedimento. Foi readmitido em unidade de Terapia Intensiva e manteve-se até 16/03/2023 apresentando boa evolução clínica. Foi feita cefazolina 1g de 8/8h durante 48 horas, compressa de gelo local por 20min a cada 4 horas nas 12h seguintes ao procedimento e analgesia regular. Paciente aceitou bem a dieta via oral e boa resposta a analgesia instaurada.

Em 15/03/2023 foi visto infiltrado em Radiografia de torax simples em hemitorax esquerdo, e o paciente referiu acompanhamento com pneumologista devido a quadro de DPOC previo (sic). Paciente estava em uso de cateter nasal de O2 sendo desmamado em 16/03/2023 mantendo boa saturação em ar ambiente. Optamos por realizar Tc de torax em 15/03/23: Pequeno derrame pleural bilateral com atelectasia compressiva do parênquima pulmonar adjacente Elevação da hem cúpula diafragmática esquerda Marcapasso parede torácica anterior esquerda Focos gasosos e infiltração da gordura na parede torácica anterior esquerda, relacionado a procedimento cirúrgico recente

No momento da alta, paciente encontra-se em bom estado geral, assintomático, mantendo ritmo de marcapasso definitivo operando em DDD com FC 75bpm. Apresenta boa e diurese espontânea em 24h, sem escapes glicêmicos, afebril e normotenso.

Converso com MA (Dr Bruno Heringer) e optamos por alta para casa com orientações e prescrição em anexo.

à disposição

Dra Mayara Farias (CRM - 52.110.419-5)

DR. BRUNO HERINGER DIAS

CARDIOLOGIA :: ARRITMIA :: MARCAPASSO

CRM: 52.76173-7

Luis Fernando Teixeira

Declaro para fins de isenção de imposto de renda na fonte, conforme Lei 9.250/1995, art. 30 e Lei 11.052/2004, art. 6º, que o paciente supracitado, sexo masculino, 74 anos, com história de obesidade mórbida desde 2006 e cirurgia bariátrica há aproximadamente 7 anos, hipertenso desde 2010, portador de DPOC (Bronquite) desde sua infância e Enfisema pulmonar há 30 anos, com história de síncope há 14 anos e necessidade de implantar portador de marcapasso definitivo bicameral nessa época por Bloqueio Atrioventricular Total. Apresentou convulsões em março de 2023 por exaustão da bateria do marcapasso e necessidade de troca em caráter de urgência, visto o risco de morte súbita.

Necessita e faz acompanhamento cardiológico regular e periódico.

Obs.: Laudo com prazo indeterminado.

CID: E66 / I10 / J449 / R00 / R00.8 / R55 / Z95.0

À disposição,

Bruno Heringer Dias

CRM: 52.76.173-7 / CPF: 011.802.116-85

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2024.

Dr. Bruno Heringer Dias
Cardiologia Arritmia e Marcapasso
CRM: 52.76173-7

MARCAÇÃO DE CONSULTAS: (21) 3577-7000 ou 99800-6697

E-MAIL: consultoriordermacor10@gmail.com

De acordo com Súmula n. 598/STJ "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". No caso

concreto, levando-se em consideração a necessidade de utilização de marcapasso, entendendo ter restado comprovada a existência de cardiopatia grave.

Ademais, vejamos:

"Quem tem marcapasso é considerado cardiopatia grave?"

*O marcapasso é recomendado para pacientes com bradicardia (frequência cardíaca lenta). A causa da bradicardia é o desgaste do sistema elétrico do coração. O desgaste pode acontecer pelo envelhecimento ou por alguma doença cardíaca. Portanto, **o marcapasso, por si só, já é um indicativo de cardiopatia grave.** "*

Assim, a parte autora faz jus a isenção do imposto de renda, devendo a sentença de procedência ser mantida.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno a recorrente vencida em honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao juizado de origem.

5069106-52.2024.4.02.5101

510014763747 .V8